# 抗衰老養生研究計劃 / Anti-Aging Wellness Research Program

**文件作者 / Author:** Manus AI

**版本 / Version:** 1.0

**日期 / Date:** 2026年2月1日

---

## 執行摘要 / Executive Summary

本研究計劃旨在系統性地驗證一套結合古代經脈智慧與現代細胞科技的非侵入性抗衰老養生系統。研究的核心目標是預防猝死、中風、失智等重大健康風險，持續改善參與者的內外健康，最終達致「無藥人生」的願景。本計劃現階段對自願參加者完全免費，並由合作的註冊醫生進行長期健康監控。

This research program aims to systematically validate a non-invasive anti-aging wellness system that integrates the wisdom of ancient meridian theory with modern cellular technology. The core objectives are to prevent major health risks such as sudden death, stroke, and dementia, continuously improve the internal and external health of participants, and ultimately achieve the vision of a "medication-free life." Participation in this program is currently free of charge for volunteers, with long-term health monitoring provided by cooperating registered physicians.

---

## 第一部分：研究背景與願景 / Part 1: Research Background and Vision

### 1.1 問題陳述 / Problem Statement

現代社會中，心血管疾病、代謝綜合症和神經退行性疾病已成為威脅中老年人健康的主要殺手。傳統的醫療模式往往側重於疾病發生後的治療，而非預防。許多人在退休後依賴大量藥物維持生命，生活質量大打折扣。

In modern society, cardiovascular diseases, metabolic syndrome, and neurodegenerative diseases have become the leading threats to the health of middle-aged and elderly individuals. Traditional medical models often focus on treatment after disease onset rather than prevention. Many people rely on a large number of medications to sustain their lives after retirement, significantly compromising their quality of life.

### 1.2 研究願景 / Research Vision

本研究的願景是探索並驗證一套有效的逆齡養生系統，使參與者能夠：

The vision of this research is to explore and validate an effective anti-aging wellness system that enables participants to:

| 願景目標 Vision Goal | 描述 Description |
|---|---|
| **預防重大疾病 Prevent Major Diseases** | 顯著降低冠心病、血栓、中風和猝死的風險。 |
| **持續改善健康 Continuously Improve Health** | 從細胞層面逆轉衰老，提升代謝、心血管和認知功能。 |
| **實現無藥人生 Achieve Medication-Free Life** | 逐步減少對處方藥物的依賴，達致健康退休。 |

## 1.3 核心療法介紹 / Introduction to Core Therapies

本研究基於以下三種核心療法的協同效應，並可選擇性地結合幹細胞治療：

This research is based on the synergistic effects of the following three core therapies, with the optional addition of stem cell therapy:

| 療法 Therapy | 作用機制 Mechanism of Action | 預期效益 Expected Benefits |
|---|---|---|
| **EECP (體外反搏)** | 通過氣囊對下肢的序貫加壓，增加心臟舒張期血流，促進側支循環建立。 | 改善心臟功能、降低心血管事件風險、改善男性勃起功能。 |
| **mHBOT (微高壓氧)** | 在微高壓環境下吸入高濃度氧氣，提高血漿溶氧量，促進細胞修復。 | 延長端粒、清除衰老細胞、增強認知功能。 |
| **紅外線治療 (Infrared)** | 利用特定波長的紅外線穿透皮膚，促進血液循環和組織修復。 | 減輕炎症、緩解疼痛、促進傷口癒合。 |
| **幹細胞治療 (Stem Cell)** | 通過靜脈注射間充質幹細胞，補充體內年輕細胞，促進組織再生。 | 替代衰老細胞、修復受損組織、釋放年輕化信號。 |

---

# 第二部分：研究方案概述 / Part 2: Research Protocol Overview

## 2.1 治療方案 / Treatment Protocols

本研究提供三種治療方案供參與者選擇：

This research offers three treatment protocols for participants to choose from:

| 方案名稱 Protocol Name | 組成 Components | 治療頻率 Frequency |
|---|---|---|
| **三合一療法 A (Triple Therapy A)** | EECP + 純氧 + 紅外線 | 每日1-2小時 |
| **三合一療法 B (Triple Therapy B)** | EECP + mHBOT + 紅外線 | 每日1-2小時 |
| **四位一體方案 (Four-in-One Protocol)** | EECP + mHBOT + 紅外線 + 幹細胞 | 每日1-2小時 + 每年1-2次幹細胞注射 |

## 2.2 預期累積效應時間表 / Expected Cumulative Effect Timeline

根據現有科學文獻和報告推斷，持續每日治療將產生以下階段性效應：

Based on existing scientific literature and report extrapolations, continuous daily treatment is expected to produce the following phased effects:

| 時間階段 Time Phase | 階段特徵 Phase Characteristics | 預期成果 Expected Outcomes |
|---|---|---|
| **短期 (1-3個月)** | 功能優化期 Functional Optimization | 精力提升、睡眠改善、代謝指標趨於穩定，主觀感覺「年輕5歲」。 |
| **中期 (6-24個月)** | 結構重塑期 Structural Remodeling | 側支循環建立、端粒延長、衰老細胞清除，生理年齡可能逆轉10-15年。 |
| **長期 (3-5年+)** | 穩態重置期 Homeostatic Reset | 衰老軌跡改變、疾病風險大幅降低，實現「無藥退休」目標。 |

---

# 第三部分：參與者招募與模式 / Part 3: Participant Recruitment and Models

## 3.1 招募原則 / Recruitment Principles

本研究現階段對所有自願參加者完全免費。所有參與者在加入時均需通過合作的註冊醫生進行首次健康狀況登記，以便對身體變化進行長期監控。

Participation in this research is currently free of charge for all volunteers. All participants are required to undergo an initial health status registration with a cooperating registered physician upon joining to enable long-term monitoring of physical changes.

## 3.2 兩種參與模式 / Two Participation Models

| 特徵 Feature | **臨床實驗組 (Clinical Study Group)** | **醫生監控組 (Physician-Monitored Group)** |
|---|---|---|
| **核心目標** | 在嚴格控制的條件下，系統性地評估特定治療方案的有效性與安全性。 | 在真實世界場景中，觀察並記錄參與者在醫生指導下接受治療的長期健康變化。 |
| **治療方案** | 標準化的治療方案，由研究團隊根據納入標準分配。 | 個性化的治療建議，由主診醫生根據參與者的具體健康狀況和需求決定。 |
| **費用** | 研究相關的治療和檢測費用全免。 | 參與者需自行承擔所有醫療費用，包括醫生診金、藥物、補充劑及檢測費用。 |
| **數據收集** | 頻繁且標準化的數據點收集。 | 定期的健康檢查和醫生訪談記錄。 |
| **適合對象** | 願意並能夠嚴格遵守標準化研究方案的個體。 | 希望在個人醫生指導下靈活接受治療，同時為研究貢獻數據的個體。 |

## 3.3 臨床實驗組詳情 / Clinical Study Group Details

**納入標準 (Inclusion Criteria):**

- 年齡介乎40-65歲
- 具有至少一項心血管疾病風險因素（如高血壓、高血脂、糖尿病前期）
- 無嚴重器官衰竭
- 同意並簽署知情同意書

**排除標準 (Exclusion Criteria):**

- 懷孕或哺乳期婦女
- 患有嚴重凝血障礙
- 體內有大型金屬植入物（不適用於特定療法）
- 正在接受癌症治療

**監控時間點 (Monitoring Timepoints):** 基線期、第3、6、12、24、36個月

### 3.4 醫生監控組詳情 / Physician-Monitored Group Details

**招募對象:** 任何自願參加並同意分享其健康數據的個體。參與者需有自己的主診醫生，並由該醫生監督其健康狀況。

**醫生角色 (Physician's Role):**

- 首次登記參與者的健康狀況
- 根據臨床判斷和患者意願制定個性化治療方案
- 跟進參與者原本服食的藥物，或作出調整
- 提供醫療上的保健補充劑或其他建議
- 定期向研究團隊提供匿名的健康報告

**費用說明:** 參與者需自行繳付醫生的費用，包括診金、藥物和檢測費用。

---

## 第四部分：AI健康紀錄數據框架 / Part 4: AI Health Record Data Framework

為了有效地監控參與者的長期健康變化並持續完善治療方案，建議建立一個標準化的AI健康紀錄數據框架。參與醫生應盡量按照此框架提供數據，以便進行系統性分析。

To effectively monitor the long-term health changes of participants and continuously refine treatment protocols, the establishment of a standardized AI Health Record Data Framework is recommended. Participating physicians should, to the best of their ability, provide data according to this framework to facilitate systematic analysis.

### 4.1 數據收集框架 / Data Collection Framework

| 數據類別 | 數據點 | 收集頻率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| **基本資料** | 年齡、性別、身高、體重、BMI | 首次登記 | 用於建立個人基線。 |
| **病史** | 既往病史、家族史、過敏史、手術史 | 首次登記 | 了解個體健康背景。 |
| **生活方式** | 吸煙狀況、飲酒習慣、運動頻率、飲食習慣、睡眠質量 | 首次及每年更新 | 評估生活方式對健康的影響。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **核心生理指標** | 靜息心率、血壓、血氧飽和度 | 每次就診 | 反映心血管系統基本狀態。 |
| **心血管功能** | 血管硬度 (PWV)、心臟射血分數 (LVEF)、心電圖 (ECG) | 每年一次 | 深度評估心血管健康和逆轉情況。 |
| **代謝指標** | 空腹血糖、糖化血紅蛋白 (HbA1c)、血脂四項 | 每半年一次 | 監控代謝綜合症風險。 |
| **炎症與衰老標記** | 高敏C反應蛋白 (hs-CRP)、端粒長度、衰老細胞比例 | 每年一次 (建議) | 評估全身炎症水平和細胞衰老速度。 |
| **主觀感受** | 精力水平、睡眠質量、認知功能、性功能、疼痛評分 | 每次就診 | 通過標準化問卷收集。 |
| **藥物與補充劑** | 處方藥物名稱、劑量、頻率；保健補充劑名稱、劑量 | 每次就診 | 記錄所有外部化學干預。 |

### 4.2 對參與醫生的建議 / Recommendations for Participating Physicians

研究團隊誠邀參與的醫生就AI健康紀錄的數據框架提供寶貴意見，以便持續性完善紀錄系統。建議醫生考慮以下方面：

The research team cordially invites participating physicians to provide valuable feedback on the AI Health Record data framework to continuously improve the recording system. Physicians are encouraged to consider the following aspects:

1. **數據點的臨床相關性 (Clinical Relevance of Data Points):** 哪些指標對於評估抗衰老療法的效果最為關鍵?
2. **收集頻率的可行性 (Feasibility of Collection Frequency):** 建議的收集頻率在臨床實踐中是否可行?
3. **額外數據點建議 (Suggestions for Additional Data Points):** 是否有其他重要的健康指標應納入框架?
4. **數據提交方式 (Data Submission Methods):** 對於數據提交的格式和方式有何建議?

---

## 第五部分：預期效益與風險 / Part 5: Expected Benefits and Risks

## 5.1 預期效益 / Expected Benefits

根據三份療法報告的推斷，參與者可能獲得以下效益：

Based on the extrapolations from the three therapy reports, participants may experience the following benefits:

| 效益類別 | 具體效益 |
| --- | --- |
| **心血管健康** | 顯著降低冠心病、血栓、中風和猝死的風險；側支循環建立形成「天然搭橋」。 |
| **代謝改善** | 血糖、血脂等代謝指標趨於正常；體重下降，體脂率降低。 |
| **認知功能** | 腦霧消除，記憶力和專注力提升；延緩與年齡相關的認知衰退。 |
| **生活質量** | 精力充沛，睡眠質量改善；性功能（如勃起功能）得到根本性改善。 |
| **逆齡效果** | 生理年齡可能逆轉5-15年；衰老軌跡被改變，進入更平緩的衰老平台期。 |
| **無藥人生** | 對處方藥物的依賴性可能降低，有望實現「健康退休，無藥人生」的目標。 |

## 5.2 潛在風險與注意事項 / Potential Risks and Precautions

所有療法均為非侵入性或微創性，風險相對較低。然而，參與者應注意以下事項：

All therapies are non-invasive or minimally invasive, with relatively low risks. However, participants should note the following:

- **EECP:** 可能出現輕微的皮膚不適或肌肉疲勞，通常在治療後消退。
- **mHBOT:** 可能出現耳壓不適，類似於乘坐飛機時的感覺。
- **紅外線:** 可能出現輕微的皮膚發紅或溫熱感。
- **幹細胞治療:** 作為微創性治療，可能存在注射部位的輕微不適或感染風險。

所有治療均應在專業醫療人員的監督下進行。

---

# 第六部分：結論與展望 / Part 6: Conclusion and Outlook

本研究計劃代表了一項開創性的嘗試，旨在結合古代經脈智慧與現代細胞科技，探索一套安全、有效的非侵入性逆齡養生系統。通過嚴謹的臨床實驗和真實世界的醫生監控數據，我們期望能夠驗證這套系統在預防重大疾病、持續改善健康和實現「無藥人生」方面的潛力。

This research program represents a pioneering effort to combine the wisdom of ancient meridian theory with modern cellular technology to explore a safe and effective non-invasive anti-aging wellness system. Through rigorous clinical trials and real-world data from physician-monitored participants, we expect to validate the potential of this system in preventing major diseases, continuously improving health, and achieving a "medication-free life."

AI健康紀錄系統的建立將是本研究的核心資產，它不僅能為個體提供精準的健康反饋，也將為抗衰老領域的科學發展貢獻寶貴的數據資源。我們誠邀有志於追求健康長壽的人士加入這項研究，共同見證並創造一個更健康的未來。

The establishment of the AI Health Record system will be a core asset of this research, not only providing precise health feedback for individuals but also contributing valuable data resources to the scientific advancement of the anti-aging field. We cordially invite individuals who aspire to healthy longevity to join this research and together witness and create a healthier future.

---

## 參考文獻 / References


1. Lishuta, A. S., et al. (2025). Cardiovascular Effects of Long-Term Treatment with Enhanced External Counterpulsation in Patients with Ischemic Heart Failure. *Journal of Cardiovascular Development and Disease*, 12(9), 352.
2. Soran, O., Kennard, E. D., Kelsey, S. F., Holubkov, R., Strobeck, J., & Feldman, A. M. (2006). Two-year clinical outcomes after enhanced external counterpulsation (EECP) therapy. *Journal of the American College of Cardiology*, 47(3), 431-436.
3. Braith, R. W., et al. (2010). Enhanced External Counterpulsation Improves Peripheral Artery Flow-Mediated Dilation in Patients With Chronic Angina. *Circulation: Heart Failure*, 3(6), 755-762.
4. Ambari, A. M., et al. (2021). External Counterpulsation Improves Angiogenesis by Preserving Vascular Endothelial Growth Factor-A and Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 8, 761112.
5. Fu, Q., et al. (2022). Hyperbaric oxygen therapy for healthy aging: From mechanisms to therapeutics. *Redox Biology*, 53, 102352.
6. Gupta, M., & Rathored, J. (2024). Hyperbaric oxygen therapy: future prospects in regenerative therapy and anti-aging. *Frontiers in Aging*, 5, 1368982.

7. El Assaad, N., et al. (2024). Anti-aging based on stem cell therapy: A scoping review. *World Journal of Experimental Medicine*, 14(3), 97233.
8. Huang, X., et al. (2023). Mesenchymal Stem/Stromal Cells Therapy for Metabolic Syndrome. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(19), 14901.
9. Cleveland Clinic. (2022). EECP Therapy (Enhanced External Counterpulsation).
10. Flow Therapy. (n.d.). The Long-term Prognosis of Angina Treated with EECP.